

医药生物周报（25 年第 23 周）

炎症性肠病数据梳理，关注具备创新资产的标的

优于大市

核心观点

本周医药板块表现弱于整体市场，化学制药板块领涨。本周全部 A 股上涨 1.42%（总市值加权平均），沪深 300 上涨 0.88%，中小板指上涨 1.62%，创业板指上涨 2.32%，生物医药板块整体上涨 1.13%，生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨 1.67%，生物制品上涨 1.00%，医疗服务上涨 0.73%，医疗器械上涨 1.11%，医药商业上涨 1.13%，中药上涨 0.39%。医药生物市盈率（TTM）34.41x，处于近 5 年历史估值的 72.02%分位数。

炎症性肠病的临床数据展示出良好的临床疗效。炎症性肠病（IBD）为一种慢性反复发作的肠道炎症性疾病，现有的药物仍存在一定的局限性，表现为药物低至中度的临床缓解率和更低的黏膜愈合率，部分药物在先前使用过生物制剂的患者中治疗效果下降，甚至随着治疗时间延长，出现无应答的情况，安全性方面仍面临长期用药会出现的免疫抑制的情况。IBD 治疗出现多个创新型的靶点，包括 TYK2 小分子、IL-23 抗体和 TL1A 抗体，临床数据显示出初步的优势，多个 MNC 药企通过 BD 或者自研的方式纷纷布局 IBD 领域，建议持续关注 IBD 领域的研发进展和布局该领域的相关公司：三生国健、益方生物、诺诚健华。

国产创新药越来越具备全球价值。2025 年 ASCO 会议顺利闭幕，国产多款创新药在会议中读出临床数据。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。近期，三生制药的 PD-1xVEGF 双抗 707 与辉瑞达成合作，首付款 12.5 亿美元刷新了国产创新药的记录；年初至今对外授权的数量和金额都保持增长。临床数据的读出有助于创新药成药性的确定以及后续在全球范围内的开发。建议关注具备高质量创新能力的公司：科伦博泰生物、康方生物、三生制药、和黄医药、泽璟制药、迪哲医药等。

风险提示：研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	总市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)				PE			
				2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E
300760.SZ	迈瑞医疗	优于大市	2819	116.7	124.1	141.0	161.9	24.2	22.7	20.0	17.4
603259.SH	药明康德	优于大市	1851	93.5	111.6	127.3	145.1	19.8	16.6	14.5	12.8
300832.SZ	新产业	优于大市	495	18.3	20.4	24.3	28.8	27.1	24.3	20.3	17.2
688617.SH	惠泰医疗	优于大市	383	6.7	8.8	11.3	14.7	56.9	43.7	33.8	26.0
300633.SZ	开立医疗	优于大市	142	1.4	3.1	4.0	4.8	99.4	45.2	35.7	29.3
688212.SH	澳华内镜	优于大市	75	0.2	0.5	1.0	1.2	358.1	139.4	76.8	60.7
300685.SZ	艾德生物	优于大市	82	2.5	3.2	3.8	4.5	32.1	25.8	21.4	18.1
688050.SH	爱博医疗	优于大市	137	3.9	4.7	5.8	7.2	35.3	29.3	23.7	19.1
603882.SH	金城医学	优于大市	139	(3.8)	6.9	8.5	-	(36.5)	20.2	16.4	-
9926.HK	康方生物	优于大市	676	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(131.4)	2331.2	92.6	37.7
6990.HK	科伦博泰生物-B	优于大市	704	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(264.0)	(97.7)	(233.2)	148.3
0013.HK	和黄医药	优于大市	192	2.7	24.9	8.5	11.8	70.9	7.7	22.5	16.3
2162.HK	康诺亚-B	优于大市	122	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(23.8)	(15.3)	(21.0)	255.1
1530.HK	三生制药	优于大市	444	20.9	23.9	27.1	30.7	21.2	18.6	16.4	14.5
1789.HK	爱康医疗	优于大市	62	2.7	3.3	4.0	4.8	22.5	18.5	15.3	12.7

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究 · 行业周报

医药生物

优于大市 · 维持

证券分析师：陈曦炳

0755-81982939

chenxibing@guosen.com.cn

S0980521120001

证券分析师：彭思宇

0755-81982723

cnpengsiyu@guosen.com.cn

S0980521060003

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《医药生物周报（25 年第 22 周）-血液净化器械行业分析，关注产业链国产替代趋势》——2025-06-04
- 《2025 ASCO 年会摘要总结——关注国产双抗、ADC 等创新分子》——2025-05-30
- 《医药生物周报（25 年第 21 周）-脓毒症治疗或迎来创新疗法，建议关注远大医药》——2025-05-26
- 《医药行业快评-ASCO 年会摘要发布，国产创新药成果丰硕》——2025-05-23
- 《海外制药企业 2025Q1 业绩回顾——美国药品价格改革叠加不确定的宏观环境》——2025-05-21

内容目录

炎症性肠病创新管线临床数据梳理	5
IBD 存在较大的未被满足的临床需求	5
IBD 现有治疗格局	6
IBD 适应症中涌现出多款创新药	15
本周行情回顾	26
板块估值情况	28
推荐标的	29
风险提示	31

图表目录

图1：中重度 UC 的标准治疗方案（基于 AGA 和 ECCO 的标准治疗方案）	5
图2：CD 的治疗指南（ECCO 2024）	6
图3：REMICADE 治疗 CD 适应症的 ACCENT I 临床有效性数据	7
图4：REMICADE 治疗 UC 适应症的临床有效性数据	7
图5：RINVOQ 治疗 CD 适应症的 CD-1 临床有效性数据（第 12 周）	8
图6：RINVOQ 治疗 CD 适应症的 CD-3 临床有效性数据（第 52 周）	9
图7：RINVOQ 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据（第 8 周）	10
图8：RINVOQ 治疗 UC 适应症的 UC-3 临床有效性数据（第 52 周）	11
图9：Ustekinumab 治疗 CD 适应症的 CD-1 和 CD-2 临床有效性数据	12
图10：Ustekinumab 治疗 CD 适应症的 CD-3 临床有效性数据（第 52 周）	12
图11：Ustekinumab 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据（第 8 周）	13
图12：Ustekinumab 治疗 UC 适应症的 UC-2 临床有效性数据（第 52 周）	13
图13：Tulisokibart 治疗 UC 适应症的临床 II 期主要终点和次要终点数据（第 12 周）	15
图14：RVT-3101 治疗 UC 适应症的临床 IIb 期数据	16
图15：Duvakitug 在 CD 适应症的临床有效性数据（第 14 周）	17
图16：Duvakitug 在 UC 适应症的临床有效性数据（第 14 周）	17
图17：Deucravacitinib 治疗 CD 适应症的临床有效性数据（LATTICE-CD 研究，第 12 周）	18
图18：Deucravacitinib 治疗 UC 适应症的临床有效性数据（LATTICE-UC 研究，第 12 周）	18
图19：Deucravacitinib 治疗 UC 适应症的临床有效性数据（IM011-127 研究，第 12 周）	19
图20：Risankizumab 治疗 CD 适应症的 CD-1 临床有效性数据（第 12 周）	20
图21：Risankizumab 治疗 CD 的 CD-2 临床数据（第 12 周）	21
图22：Risankizumab 治疗 CD 的 CD-3 临床数据（第 52 周）	21
图23：Risankizumab 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据（第 12 周）	21
图24：Risankizumab 治疗 UC 适应症的 UC-2 临床有效性数据（第 52 周）	22
图25：Guselkumab 治疗 UC 适应症的临床 III 期研究数据（第 12 周）	23
图26：Guselkumab 治疗 UC 适应症的临床 III 期研究数据（维持期第 44 周）	24
图27：申万一级行业一周涨跌幅（%）	26
图28：申万一级行业市盈率情况（TTM）	28
图29：医药行业子板块一周涨跌幅（%）	28
图30：医药行业子板块市盈率情况（TTM）	28

表1: CD 适应症中已获批上市的药物	14
表2: UC 适应症中已获批上市的药物	14
表3: TL1A 靶点分子商业化合作交易梳理	17
表4: TYK2 和 TL1A 靶点药物在 IBD 适应症中的竞争格局	19
表5: CD 适应症中 IL-23 和 TL1A 抗体的临床数据对比	24
表6: UC 适应症中 IL-23 和 TL1A 抗体的临床数据对比	25
表7: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况	27

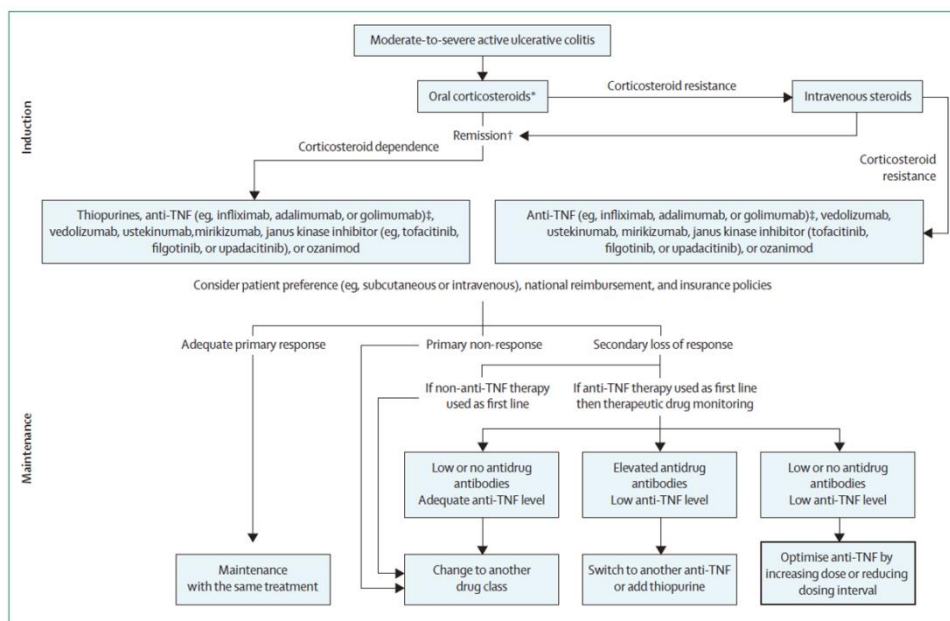
炎症性肠病创新管线临床数据梳理

IBD 存在较大的未被满足的临床需求

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)以反复腹痛、腹泻、血便和体重降低为主要表现，根据临床表现与治疗手段的不同，主要分为溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn's disease, CD)两种类型。病变可以累及肠道的任何节段，患者病情严重程度不同，常表现为缓解和复发反复交替出现，严重的时候需要住院治疗。2019 年，全球 IBD 患者的数量约为 490 万人，其中中国和美国患者数量排在前列，分别约有 91 万名和 76 万名患者。根据流行病学数据显示，近 20 年来西方发达国家的 IBD 发病率开始趋于平稳，新型工业城市（如中东、亚洲、南美洲等）的 IBD 患者新发病人数量增长较快，对各国医疗健康系统造成一定的压力。

溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis, UC)的发病机制复杂，通常与肠道上皮屏障破坏、免疫反应失调及菌群失调等相关，肠道屏障受损后会激活下游炎症因子。疾病的发展主要分为轻度、中度、重度三个阶段，临床中通常会对患者进行 Mayo 评分、Lichtiger 评分（主要用于急性严重溃疡性结肠炎）以及简单临床结肠炎活动指数评估，以判断疾病的进展。中重度 UC 患者诱导期的一线治疗通常采用口服激素类药物，症状缓解后进入维持期治疗。**UC 患者诱导期出现激素依赖或耐药后通常采取硫唑嘌呤、抗 TNF 类药物（如：英夫利昔单抗、阿达木单抗或戈利木单抗）、整合素拮抗剂（vedolizumab）、白细胞介素抑制剂（ustekinumab、mirikizumab）、JAK 抑制剂（tofacitinib、filgotinib、upadacitinib）和 S1P 受体调节剂（ozanimod）。UC 患者进入维持治疗阶段，初始治疗响应的患者继续采取原有的治疗方案。不响应的患者，通常根据一线是否使用过 TNF 抗体进一步选择换用其他药物，或更改给药剂量、调整给药间隔。**

图1：中重度 UC 的标准治疗方案（基于 AGA 和 ECCO 的标准治疗方案）



资料来源：Le Berre C, Honap S, Peyrin-Biroulet L. Ulcerative colitis. Lancet. 2023 Aug 12;402(10401):571-584, 国信证券经济研究所整理

克罗恩病 (Crohn's disease, CD) 的致病机制复杂, 主要诱因包括有害的病原入侵、肠道屏障损坏或一些基因发生突变, 激活免疫细胞释放多种促炎因子。2024 年, ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation, 欧洲克罗恩病和结肠炎组织) 给出针对 CD 的标准治疗方案。**诱导期的 CD 患者推荐使用肠道释放的激素类药物、英夫利西单抗 (TNF α 抗体)、阿达木单抗 (TNF α 抗体)、维得利珠单抗 ($\alpha 4\beta 7$ 整合素抗体)、乌司奴单抗 (IL-12/23 抗体)、瑞莎珠单抗 (IL-23p19 抗体)、乌帕替尼 (JAK 抑制剂), 不推荐使用硫嘌呤单药治疗。进入维持期的 CD 患者推荐使用英夫利西单抗、阿达木单抗、维得利珠单抗、乌司奴单抗、瑞莎珠单抗、乌帕替尼, 不推荐使用全身/肠道释放类激素药物。针对 65 岁以上的 CD 患者, 推荐使用肠道释放的激素类药物、英夫利西单抗、阿达木单抗、维得利珠单抗、乌司奴单抗, 不推荐使用硫嘌呤单药治疗。**

图2: CD 的治疗指南 (ECCO 2024)

	Induction i	Maintenance i	Perianal disease ii	Peripheral Spondyloarthropathy	Axial Spondyloarthropathy	Pregnancy iii	Over 65 years
Systemic corticosteroids	iv			iv	iv	iv	iv
Enteral release corticosteroids						v	v
Enteral Nutrition							
Thiopurines monotherapy						vi	vii
Methotrexate							
Infliximab							
Adalimumab							
Certolizumab							
Vedolizumab							
Ustekinumab							
Risankizumab				vii	ix		
Upadacitinib			x	xi	xii		xiii

Recommended
Can be considered
Not recommended
Insufficient evidence

DRUGS SHOULD BE CONSIDERED BY MERIT, NOT SEQUENCED AS CONVENTIONAL TO ADVANCED

资料来源: Gordon H, Minozzi S et.al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2024 Oct 15;18(10):1531-1555, 国信证券经济研究所整理

IBD 现有治疗格局

Infliximab (英夫利西单抗, 商品名 REMICADE) 为强生研发的 TNF 抑制剂, 获批治疗成人/儿童 IBD、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等炎症性疾病。

成人 CD 适应症的获批基于两个随机、双盲、安慰剂对照的临床研究。入组患者克罗恩病活动指数 (CDAI) 为 220-400, 对常规疗法不响应。108 名患者接受 5 mg/kg REMICADE 治疗, 第 4 周的临床响应率分别为 81% (REMICADE, n=27) vs 16% (对照组, n=25), 临床缓解率 (CDAI < 150) 分别为 48% vs 4%。ACCENT I 多治疗剂量的临床入组 545 名 CD 患者, 全部患者接受 5 mg/kg 治疗后 (第 0 周), 随机分配到安慰剂组、5 mg/kg 和 10 mg/kg 组, 在第 2/6 周给药, 进入维持期后继续每

8 周给药一次。临床数据显示，57%的患者在第 2 周出现临床响应，第 30 周临床缓解率分别为 46% (10mg/kg, n=105) vs 39% (5mg/kg, n=104) vs 25% (安慰剂, n=102)，第 54 周激素类药物停用的缓解率分别为 34% (n=53) vs 25% (n=56) vs 11% (n=54)。

图3: REMICADE 治疗 CD 适应症的 ACCENT I 临床有效性数据

	Single 5-mg/kg Dose ^a	Three-Dose Induction ^b	
	Placebo Maintenance	REMICADE Maintenance q8 wks	
		5 mg/kg	10 mg/kg
Week 30	25/102	41/104	48/105
Clinical remission	25%	39%	46%
P-value ^c		0.022	0.001
Week 54	6/54	14/56	18/53
Patients in remission able to discontinue corticosteroid use ^d	11%	25%	34%
P-value ^c		0.059	0.005

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

在成人 UC 适应症的获批基于两项临床研究数据，临床共入组 728 名中重度活动期 UC 患者，Mayo 评分为 6-12，内镜评分 ≥ 2 ，对常规口服治疗药物不响应。UC I 临床中患者在第 0/2/6 周接受 5 mg/kg 或 10 mg/kg REMICADE 或安慰剂治疗，后续每 8 周给药一次，持续给药 46 周。有效性数据显示，患者在治疗第 8 周出现较好的临床响应率 62% (10 mg/kg, n=122) vs 69% (5 mg/kg, n=121) vs 37% (安慰剂, n=121)，临床缓解率分别为 32% vs 39% vs 15%，粘膜愈合率分别为 59% vs 62% vs 34%；到第 54 周，临床响应率分别为 44% (10 mg/kg, n=122) vs 45% (5 mg/kg, n=121) vs 20% (安慰剂, n=121)，临床缓解率分别为 34% vs 35% vs 17%，粘膜愈合率分别为 47% vs 45% vs 18%。

图4: REMICADE 治疗 UC 适应症的临床有效性数据

	Study UC I			Study UC II		
	Placebo	5 mg/kg REMICADE	10 mg/kg REMICADE	Placebo	5 mg/kg REMICADE	10 mg/kg REMICADE
Patients randomized	121	121	122	123	121	120
Clinical Response^{a, d}						
Week 8	37%	69%*	62%*	29%	65%*	69%*
Week 30	30%	52%*	51%**	26%	47%*	60%*
Week 54	20%	45%*	44%*	NA	NA	NA
Sustained Response^d						
(Clinical response at both Weeks 8 and 30)	23%	49%*	46%*	15%	41%*	53%*
(Clinical response at Weeks 8, 30, and 54)	14%	39%*	37%*	NA	NA	NA
Clinical Remission^{b, d}						
Week 8	15%	39%*	32%**	6%	34%*	28%*
Week 30	16%	34%**	37%*	11%	26%**	36%*
Week 54	17%	35%**	34%**	NA	NA	NA

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

Upadacitinib（乌帕替尼，商品名 RINVOQ）为艾伯维研发的 JAK 抑制剂，目前已经获批用于治疗银屑病、IBD、特应性皮炎等炎症疾病。

在 CD 适应症中开展的两项临床研究，共入组 857 名患者（CD-1 临床 419 名，CD-2 临床 438 名），患者基线 CDAI 评分至少为 220，简单内镜评分为 ≥ 6 或 ≥ 4 （孤立性回肠病变）。CD-1 临床患者均接受过 1 种或多种生物制剂治疗后失败，CD-2 临床中 45% 的患者接受过生物制剂治疗后失败。治疗方案为每天给予 45 mg RINVOQ 或安慰剂治疗，持续 12 周。第 12 周的有效性数据显示，CD-1 临床治疗组和对照组的临床缓解率分别为 36%（n=273）vs 18%（n=146），内镜响应率分别为 34% vs 3%，临床响应率（CDAI 减少 100）分别为 54% vs 31%，糖皮质激素停用的临床缓解率为 30%（n=96）vs 11%（n=53）。

图5: RINVOQ 治疗 CD 适应症的 CD-1 临床有效性数据（第 12 周）

Endpoint	Placebo	RINVOQ 45 mg Once Daily	Treatment Difference vs Placebo (95% CI)
Co-Primary Endpoints at Week 12			
Clinical remission^a	N=146 18%	N=273 36%	17% (9, 25)*
Endoscopic response^b	N=146 3%	N=273 34%	30% (24, 36)*
Additional Endpoints at Week 12			
Clinical response (CR-100)^c	N=146 31%	N=273 54%	22% (13, 31)*
Corticosteroid-free clinical remission in patients on corticosteroids at baseline^{a,d}	N=53 11%	N=96 30%	17% (5, 29)**
Endoscopic remission^e	N=146 3%	N=273 19%	15% (10, 21)*

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

维持治疗的 CD-3 临床研究中，343 名患者第 12 周出现响应，继续接受每天一次 15 mg 或 30 mg RINVOQ 或安慰剂的维持治疗，持续治疗至第 52 周。第 52 周的数据显示，30 mg、15 mg 和安慰剂组的临床缓解率分别为 55%（n=119）vs 42%（n=113）vs 14%（n=111），生物制剂治疗失败的患者仍有临床缓解，缓解率为 54%（n=90）vs 35%（n=85）vs 13%（n=87），整体的内镜响应率分别为 41% vs 28% vs 7%，生物制剂失败的内镜响应率为 42% vs 22% vs 5%。

图6: RINVOQ 治疗 CD 适应症的 CD-3 临床有效性数据 (第 52 周)

Endpoint	Placebo ⁺	RINVOQ 15 mg Once Daily	RINVOQ 30 mg Once Daily	Treatment Difference 15 mg vs Placebo (95% CI)	Treatment Difference 30 mg vs Placebo (95% CI)
Co-Primary Endpoints					
Clinical remission ^a					
Total population	N=111 14%	N=113 42%	N=119 55%	29% (18, 39) ⁺	40% (29, 51) ⁺
Prior biologic failure	N=87 13%	N=85 35%	N=90 54%		
Without prior biologic failure	N=24 21%	N=28 61%	N=29 55%		
Endoscopic response ^b					
Total population	N=111 7%	N=113 28%	N=119 41%	22% (13, 32) ⁺	34% (25, 44) ⁺
Prior biologic failure	N=87 5%	N=85 22%	N=90 42%		
Without prior biologic failure	N=24 17%	N=28 45%	N=29 38%		
Additional Endpoints					
Corticosteroid-free clinical remission ^c					
Total population	N=111 14%	N=113 42%	N=119 53%	29% (18, 39) ⁺	38% (27, 49) ⁺
Prior biologic failure	N=87 13%	N=85 35%	N=90 52%		

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

在成人 UC 适应症中, UC-1 和 UC-2 两个临床共入组 988 名患者, 51% 的患者既往至少使用过一种生物制剂, 2:1 随机分为 45 mg RINVOQ 和安慰剂组, 每天给药一次, 持续治疗 8 周。UC-1 临床研究的第 8 周数据显示, 45 mg RINVOQ 和安慰剂组的临床缓解率分别为 26% (n=319) vs 5% (n=154), 其中生物制剂治疗失败的临床缓解率分别为 18% (n=168) vs <1% (n=78), 临床响应率分别为 73% vs 27%, 生物制剂失败的临床响应率分别为 64% vs 13%, 内镜改善率分别为 36% vs 7%, 组织学内镜黏膜改善率分别为 30% vs 7%。

图7: RINVOQ 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据 (第 8 周)

Endpoint	Placebo	RINVOQ 45 mg Once Daily	Treatment Difference vs Placebo (95% CI)
Clinical Remission ^a			
Total Population	N=154 5%	N=319 26%	22% ^b (16, 27)
Prior biologic failure ^c	N=78 < 1%	N=168 18%	
Without prior biologic failure	N=76 9%	N=151 35%	
Clinical Response ^d			
Total Population	N=154 27%	N=319 73%	46% ^b (38, 54)
Prior biologic failure ^c	N=78 13%	N=168 64%	
Without prior biologic failure	N=76 42%	N=151 82%	
Endoscopic Improvement ^e			
Total Population	N=154 7%	N=319 36%	29% ^b (23, 36)
Prior biologic failure ^c	N=78 2%	N=168 27%	
Without prior biologic failure	N=76 13%	N=151 47%	
Histologic Endoscopic Mucosal Improvement ^f			
Total Population	N=154 7%	N=319 30%	24% ^b (17, 30)
Prior biologic failure ^c	N=78 1%	N=168 23%	
Without prior biologic failure	N=76 12%	N=151 38%	

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

在 UC-1、UC-2、UC-4 临床中 45 mg RINVOQ 治疗出现临床响应的 451 名患者继续采取每日一次的 15 mg、30 mg 或安慰剂 RINVOQ 维持治疗, 持续治疗至第 52 周。第 52 周的数据显示, 30 mg、15 mg RINVOQ 和安慰剂治疗的患者临床缓解率分别为 52% vs 42% vs 12%, 生物制剂失败的患者临床缓解率为 49% (n=73) vs 41% (n=71) vs 7% (n=81), 糖皮质激素停用的临床缓解率为 68% (n=58) vs 57% (n=47) vs 22% (n=54), 整体的内镜改善率为 62% vs 49% vs 14%, 组织学内镜黏膜改善率为 50% vs 35% vs 12%。

图8: RINVOQ 治疗 UC 适应症的 UC-3 临床有效性数据 (第 52 周)

Endpoint	Placebo	RINVOQ 15 mg Once Daily	Treatment Difference 15 mg vs Placebo (95% CI)	RINVOQ 30 mg Once Daily	Treatment Difference 30 mg vs Placebo (95% CI)
Clinical remission ^a					
Total Population	N=149 12%	N=148 42%	31% ^b (22, 40)	N=154 52%	39% ^b (30, 48)
Prior biologic failure ^c	N=81 7%	N=71 41%		N=73 49%	
Without prior biologic failure	N=68 18%	N=77 44%		N=81 54%	
Corticosteroid-free clinical remission ^d					
Total Population	N=54 22%	N=47 57%	35% ^b (18, 53)	N=58 68%	45% ^b (29, 62)
Prior biologic failure ^c	N=22 14%	N=17 71%		N=20 73%	
Without prior biologic failure	N=32 28%	N=30 49%		N=38 65%	
Endoscopic Improvement ^e					
Total Population	N=149 14%	N=148 49%	34% ^b (25, 44)	N=154 62%	46% ^b (37, 56)
Prior biologic failure ^c	N=81 8%	N=71 43%		N=73 56%	
Without prior biologic failure	N=68 22%	N=77 54%		N=81 67%	
Histologic Endoscopic Mucosal Improvement ^f					
Total Population	N=149 12%	N=148 35%	24% ^b (15, 33)	N=154 50%	37% ^b (28, 47)
Prior biologic failure ^c	N=81 5%	N=71 33%		N=73 48%	
Without prior biologic failure	N=68 20%	N=77 37%		N=81 52%	

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

Ustekinumab (乌司奴单抗, 商品名 STELARA) 为强生开发的 IL-12/23 抗体, 目前已经获批用于斑块状银屑病、银屑病关节炎和 IBD。

Ustekinumab 在 CD 中获批基于两项临床研究, 研究共入组 1409 名患者, 其中对 1368 名患者数据进行评估 (CD-1 有 741 名, CD-2 有 627 名), 治疗方案为单药静脉注射 6 mg/kg Ustekinumab 或安慰剂 (或者以 130 mg 更低剂量 Ustekinumab 治疗)。

CD-1 临床的患者中, 48% 的患者接受过一种 TNF 拮抗剂治疗后失败或不耐受, 52% 的患者接受 2/3 种 TNF 拮抗剂治疗失败, 约 46% 患者持续使用糖皮质激素, 约 31% 患者持续使用免疫调节剂, Ustekinumab 和安慰剂组基线中位 CDAI 评分分别为 319 和 313。CD-2 临床 81% 的患者糖皮质激素治疗失败或不耐受, 68% 的患者接受过至少一种免疫调节剂, 69% 的患者未接受过 TNF 拮抗剂, 约 39% 的患者持续使用糖皮质激素, 约 35% 的患者持续使用免疫调节剂。第 8 周的数据显示, CD-1 临床中 Ustekinumab (n=249) 和安慰剂组 (n=247) 的临床响应率分别为 38% vs 20%, 临床缓解率分别为 21% vs 7%; CD-2 临床中 Ustekinumab (n=209) 和安慰剂组 (n=209) 的临床响应率分别为 58% vs 32%, 临床缓解率分别为 40% vs 20%。

图9: Ustekinumab 治疗 CD 适应症的 CD-1 和 CD-2 临床有效性数据

	CD-1 n = 741			CD-2 n = 627		
	Placebo N = 247	Ustekinumab † N = 249	Treatment difference and 95% CI	Placebo N = 209	Ustekinumab † N = 209	Treatment difference and 95% CI
Clinical Response (100 point), Week 6	53 (21%)	84 (34%) ^a	12% (4%, 20%)	60 (29%)	116 (56%) ^b	27% (18%, 36%)
Clinical Remission, Week 8	18 (7%)	52 (21%) ^b	14% (8%, 20%)	41 (20%)	84 (40%) ^b	21% (12%, 29%)
Clinical Response (100 point), Week 8	50 (20%)	94 (38%) ^b	18% (10%, 25%)	67 (32%)	121 (58%) ^b	26% (17%, 35%)
70 Point Response, Week 6	75 (30%)	109 (44%) ^a	13% (5%, 22%)	81 (39%)	135 (65%) ^b	26% (17%, 35%)
70 Point Response, Week 3	67 (27%)	101 (41%) ^a	13% (5%, 22%)	66 (32%)	106 (51%) ^b	19% (10%, 28%)

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

维持治疗阶段共有 388 名患者进入 CD-3 临床, 皮下给与 90 mg Ustekinumab 或安慰剂治疗, 每 8 周给药一次, 持续治疗 44 周。第 52 周的数据显示, 90 mg Ustekinumab (n=128) 和安慰剂组 (n=131) 临床缓解率分别为 53% vs 36%, 临床响应率分别为 59% vs 44%。

图10: Ustekinumab 治疗 CD 适应症的 CD-3 临床有效性数据 (第 52 周)

	Placebo* N = 131 [†]	90 mg Ustekinumab every 8 weeks N = 128 [†]	Treatment difference and 95% CI
Clinical Remission	47 (36%)	68 (53%) ^a	17% (5%, 29%)
Clinical Response	58 (44%)	76 (59%) ^b	15% (3%, 27%)
Clinical Remission in patients in remission at the start of maintenance therapy**	36/79 (46%)	52/78 (67%) ^a	21% (6%, 36%)

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

UC 适应症中, 诱导期共入组 961 名患者, 接受 6 mg/kg Ustekinumab 或安慰剂 (或者以 130mg 更低剂量 Ustekinumab) 治疗, 其中 46% 的患者曾接受过激素或免疫调节剂治疗失败, 但未用过生物制剂, 3% 的患者接受过生物制剂治疗但未失败。第 8 周的数据显示, Ustekinumab (n=322) 和安慰剂组 (n=319) 的临床缓解率分别为 19% vs 7%, 其中生物制剂治疗失败的临床缓解率为 14% (n=166) vs 4% (n=161); 内镜改善率为 25% vs 13%, 临床响应率为 58% vs 31%, 组织学内镜黏膜改善率为 17% vs 8%。

图11: Ustekinumab 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据 (第 8 周)

Endpoint	Placebo N = 319		Ustekinumab [†] N = 322		Treatment difference and 97.5% CI ^a
	N	%	N	%	
Clinical Remission*	22	7%	62	19%	12% (7%, 18%) ^b
Bio-naïve [‡]	14/151	9%	36/147	24%	
Prior biologic failure	7/161	4%	24/166	14%	
Endoscopic Improvement[§]	40	13%	80	25%	12% (6%, 19%) ^b
Bio-naïve [‡]	28/151	19%	43/147	29%	
Prior biologic failure	11/161	7%	34/166	20%	
Clinical Response*	99	31%	186	58%	27% (18%, 35%) ^b
Bio-naïve [‡]	55/151	36%	94/147	64%	
Prior biologic failure	42/161	26%	86/166	52%	
Histologic-Endoscopic Mucosal Improvement[‡]	26	8%	54	17%	9% (3%, 14%) ^b
Bio-naïve [‡]	19/151	13%	30/147	20%	
Prior biologic failure	6/161	4%	21/166	13%	

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

维持阶段共有 523 名患者，分别接受 90 mg Ustekinumab (Q8W)、低于推荐剂量的 Ustekinumab (Q12W) 或安慰剂治疗，持续治疗 44 周，第 52 周的数据显示，90 mg Ustekinumab (Q8W, n=176) 和对照组 (n=175) 的临床缓解率分别为 45% vs 26%，内镜改善率分别为 47% vs 27%，激素停用的临床缓解率分别为 43% vs 26%，其中生物制剂治疗失败的临床缓解率分别为 41% (n=91) vs 18% (n=88)，内镜改善率分别为 42% vs 20%，激素停用的临床缓解率分别为 38% vs 17%。

图12: Ustekinumab 治疗 UC 适应症的 UC-2 临床有效性数据 (第 52 周)

Endpoint	Placebo [*] N = 175 [†]		90 mg Ustekinumab every 8 weeks N = 176		Treatment difference and 95% CI
	N	%	N	%	
Clinical Remission**	46	26%	79	45%	19% (9%, 28%) ^a
Bio-naïve [‡]	30/84	36%	39/79	49%	
Prior biologic failure	16/88	18%	37/91	41%	
Maintenance of Clinical Response at Week 44[†]	84	48%	130	74%	26% (16%, 36%) ^a
Bio-naïve [‡]	49/84	58%	62/79	78%	
Prior biologic failure	35/88	40%	64/91	70%	
Endoscopic Improvement[§]	47	27%	83	47%	20% (11%, 30%) ^a
Bio-naïve [‡]	29/84	35%	42/79	53%	
Prior biologic failure	18/88	20%	38/91	42%	
Corticosteroid-free Clinical Remission[‡]	45	26%	76	43%	17% (8%, 27%) ^a
Bio-naïve [‡]	30/84	36%	38/79	48%	
Prior biologic failure	15/88	17%	35/91	38%	
Maintenance of Clinical Remission at Week 44 in subjects who achieved clinical remission 8 weeks after induction	18/50	36%	27/41	66%	31% (12%, 50%) ^b
Bio-naïve [‡]	12/27	44%	14/20	70%	
Prior biologic failure	6/23	26%	12/18	67%	

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

对比已上市的几款药物的临床数据，部分治疗方案仍存在激素依赖或者耐药的情况，临床或内镜响应和缓解率仍有进一步提升的空间，因此在 IBD 领域仍有临床

未满足的需求。

表1: CD 适应症中已获批上市的药物

商品名	REMICADE						RINVOQ				STELARA			
通用名	infliximab						upadacitinibq				Ustekinumab			
研发企业	强生						艾伯维				强生			
靶点	TNF						JAK				IL-12			
适应症	中重度活动期 CD						中重度活动期 CD				中重度活动期 CD			
剂量程序	首次 5mg/kg; 维持期安慰剂、5mg/kg 第 2/6 周给药, 后安慰剂、5mg/kg 或 10mg/kg Q8W						45mg QD 12w				6mg/kg 或 130mg IV			
患者人数	n=108													
患者基线	对照组 5mg/kg													
disease duration, year, mean (SD)														
CDAI score, mean (SD)											319 313 290 286			
SES-CD, mean (SD)														
治疗背景														
induction (8w)	n=25(4w)n=27 (4w)						n=146	n=273	n=143	n=295	n=247	n=249	n=209	n=209
Clinical Remission	4% 48%						18%	36%	23%	46%	7%	21%	20%	40%
Clinical Response	16% 81% 57%						31%	54%	40%	64%	20%	38%	32%	58%
Endoscopic Response							3%	34%	13%	46%				
Endoscopic Remission							3%	19%	8%	30%				
Glucocorticoid-free Clinical Remission							11% (n=53)	30% (n=96)						
maintenance (52w)	对照组 5mg/kg 10mg/kg						对照组 15mg QD 30mg QD				对照组 90mg SC Q8W			
患者数	n=102 n=104 n=105						n=111 n=113 n=119				n=131 n=128			
Clinical Remission	25% 39% 46%						14% 42% 55%				36% 53%			
Clinical Response											44% 59%			
Endoscopic Remission							5% 19% 30%							
Endoscopic Response							7% 28% 41%							
Glucocorticoid-free Clinical Remission							14% 42% 53%							
数据来源	药品说明书						药品说明书				药品说明书			

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

表2: UC 适应症中已获批上市的药物

商品名	REMICADE						RINVOQ				STELARA	
通用名	infliximab						upadacitinibq				Ustekinumab	
研发企业	强生						艾伯维				强生	
靶点	TNF						JAK				IL-12	
适应症	中重度活动期 UC						中重度活动期 UC				中重度活动期 UC	
剂量程序	5mg/kg 或 10mg/kg 第 0/2/6 周, 后续 Q8W 46w0/2/6 周, 后续 Q8W 22w						45mg QD 8w				6 mg/kg 或 130mg IV	
患者人数	n=121	n=121	n=122	n=123	n=121	n=120	n=154	n=319	n=174	n=341	n=319	n=322
患者基线												
disease duration	6-12											
Modified Mayo scale	≥ 2											
Endoscopic subscore												
治疗背景	61%口服糖皮质激素经治, 51%口服糖皮质激素经治, 49% 6-MP/AZA 经治, 70% 43% 6-MP/AZA 经治, 75% 氨基水杨酸经治						51%既往至少用过一种生物制剂				46%激素或免疫调节剂失败, 但未用过生物制剂, 3%用过生物制剂未失败	
induction (8w)	对照组	5mg/kg	10mg/kg	对照组	5mg/kg	10mg/kg	对照组	45mg	对照组	45mg	对照组	6mg/kg
Clinical Remission	15%	39%	32%	6%	34%	28%	5%	26%	4%	33%	7%	19%
Clinical Response	37%	69%	62%	29%	65%	69%	27%	73%	25%	74%	31%	58%
Endoscopic Response												
Endoscopic Remission												
Mucosal Healing	34%	62%	59%	31%	60%	62%	7%	30%	6%	37%	8%	17%

maintenance (52/54w)							对照组	15mg QD	30mg QD	对照组	90mg Q8W
患者数							n=149	n=148	n=154	n=175	n=176
Clinical Remission							12%	42%	52%	26%	45%
Clinical Response							20%	45%	44%	NA	NA
Endoscopic Remission							17%	35%	34%	NA	NA
Endoscopic Response							18%	45%	47%	NA	NA
Mucosal Healing							12%	35%	50%	NA	NA
数据来源							药品说明书			药品说明书	

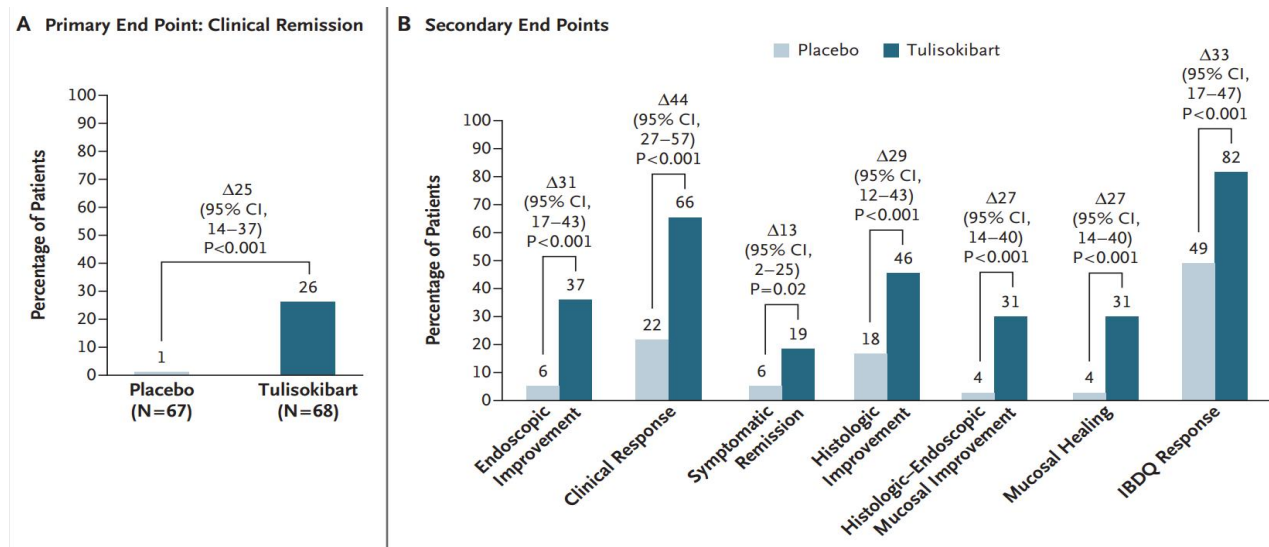
资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

IBD 适应症中涌现出多款创新药

默沙东：Tulisokibart (TL1A 抗体)

Tulisokibart/PRA023 为默沙东收购 Prometheus 公司获得的一款 TL1A 抗体，针对 UC 开展临床 II 期研究，临床 II 期数据的结果于 2024 年发表在《新英格兰医学杂志》。入组患者为糖皮质激素依赖、常规/新型疗法失败的中重度活动期 UC 病人，静脉注射 Tulisokibart（第一天给药 1000 mg，第 2/6/10 周分别给与 500 mg），以安慰剂组作为对照。研究分为两个亚组，Cohort 1 入组的患者不区分基因表达，Cohort 2 入组的患者基因检测结果为阳性。Cohort 1 共入组 135 名患者，按 1:1 随机分为 Tulisokibart 治疗组和对照组。治疗 12 周的数据显示，Tulisokibart 组 26% 的患者达到临床缓解的主要终点，对照组仅为 1% ($P < 0.001$)；次要终点数据显示，Tulisokibart 治疗组和对照组的内镜改善的比例分别为 37% vs 6%，临床响应的比例分别为 66% vs 22% ($P < 0.001$)。

图13: Tulisokibart 治疗 UC 适应症的临床 II 期主要终点和次要终点数据（第 12 周）



资料来源：Sands BE, Feagan BG, Peyrin-Biroulet L et.al. Phase 2 Trial of Anti-TL1A Monoclonal Antibody Tulisokibart for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2024 Sep 26;391(12):1119-1129.，国信证券经济研究所整理

罗氏：RVT-3101 (TL1A 抗体)

RVT-3101 (R07790121) 为罗氏收购 Telavant 公司获得的一款 TL1A 单抗，目前处于临床 III 期研究阶段，是全球第 2 款进入临床 III 期的 TL1A 抗体，2025 年欧洲克罗恩病和结肠炎组织大会 (ECCO) 公布在 UC 适应症中的临床 IIb 期研究数据。临床共入组 245 名患者，其中 228 名患者完成诱导期治疗，224 名患者进入维持

期治疗，178 名患者完成维持期治疗。在诱导期阶段，设置不同的给药剂量，分为 50 mg (n=40)、150 mg (n=53)、450 mg (n=82) 和对照组 (PBO, n=41)。第 14 周的数据显示，出现病理学改善的患者比例分别为 40.0% vs 39.6% vs 32.9% vs 12.2%，病理学缓解的患者比例分别为 35.0% vs 35.8% vs 30.5% vs 4.9%，病理学内镜黏膜改善的患者比例分别为 30.0% vs 32.1% vs 25.6% vs 4.9%。在维持期阶段，50mg、150mg 和 450mg 剂量组分别有 37、25、26 名患者，第 52 周的数据显示，病理学改善的比例分别为 40.5% vs 48.0% vs 30.8%，病理学缓解的患者比例分别为 32.4% vs 40.0% vs 23.1%。

图14: RVT-3101 治疗 UC 适应症的临床 IIb 期数据

Induction, Week 14	PBO (n=41)	50mg (n=40)	150mg (n=53)	450mg (n=82)
Histologic improvement*, %	12.2	40.0	39.6	32.9
Difference between RO7790121 and PBO, % (90% CI)	N/A	27.8 (12.1–42.8)	27.4 (12.7–40.9)	20.7 (7.5–32.1)
Histologic remission†, %	4.9	35.0	35.8	30.5
Difference between RO7790121 and PBO, % (90% CI)	N/A	30.1 (16.6–44.0)	31.0 (18.3–43.2)	25.6 (14.4–35.5)
Histologic-endoscopic mucosal improvement‡, %	4.9	30.0	32.1	25.6
Difference between RO7790121 and PBO, % (90% CI)	N/A	25.1 (12.1–38.8)	27.2 (14.8–39.3)	20.7 (9.9–30.4)
Histologic-endoscopic mucosal remission§, %	4.9	27.5	28.3	23.2
Difference between RO7790121 and PBO, % (90% CI)	N/A	22.6 (9.9–36.2)	23.4 (11.4–35.4)	18.3 (7.6–27.7)
Maintenance, Week 56¶	N/A†	50mg (n=37)	150mg (n=25)	450mg (n=26)
Histologic improvement*, %		40.5	48.0	30.8
Histologic remission†, %		32.4	40.0	23.1
Histologic-endoscopic mucosal improvement‡, %		27.0	40.0	23.1
Histologic-endoscopic mucosal remission§, %		24.3	32.0	19.2

资料来源：2025 ECCO，国信证券经济研究所整理

赛诺菲：Duvakitug (TL1A 抗体)

Duvakitug 是赛诺菲与 Teva 公司合作开发的一款 TL1A 抗体，在 UC 和 CD 两个适应症中开展临床研究，2025 年 ECCO 会议中公布临床 IIb 期数据 (RELIEVE UCDD)。

在 CD 亚组中，共入组 138 名中重度活动期 CD 患者，对标准治疗和/或新型疗法不响应或不耐受。治疗方案为，皮下注射 2250 mg Duvakitug 或安慰剂，后续继续每两周接受一次 450 mg、900 mg 剂量 Duvakitug 治疗或安慰剂治疗，每组各 46 名患者，研究达到主要临床终点。第 14 周的数据显示，患者内镜响应发生率分别为 26% (450 mg) vs 48% (900 mg) vs 13% (对照组)，其中新型疗法经治的患者内镜响应率分别为 11% (450mg, n=27) vs 48% (900mg, n=27) vs 4% (安慰剂, n=24)，在未接受过新型疗法的患者中，内镜响应率分别为 47% (450mg, n=19) vs 47% (900mg, n=19) vs 23% (安慰剂, n=22)。

在 UC 亚组中，共入组 137 名患者，皮下注射 2250 mg Duvakitug 或安慰剂，后续继续每两周接受一次 450 mg (n=47)、900 mg (n=46) 剂量 Duvakitug 或安慰剂

(n=44) 治疗, 两个剂量均到达 14 周临床改善的主要临床终点, 临床改善的比例分别为 36% (450 mg) vs 48% (900 mg) vs 20% (对照组), 其中新型疗法经治的临床缓解率分别为 29% (450mg, n=14) vs 36% (900mg, n=14) vs 7% (安慰剂, n=15), 新型疗法未经治的临床缓解率分别为 39% (450mg, n=33) vs 53% (900mg, n=32) vs 28% (安慰剂, n=29)。

图15: Duvakitug 在 CD 适应症的临床有效性数据 (第 14 周)

Table 2: Week 14 endoscopic response rates (SES-CD)

Endoscopic Response (SES-CD ≥50%)	Placebo	Duvakitug 450 mg	Duvakitug 900 mg
Total population (N)	N=46	N=46	N=46
Response rate	13%	26%	48%
Placebo-adjusted rate		13%	35%
Advanced therapy experienced (N)	N=24	N=27	N=27
Response rate	4%	11%	48%
Placebo-adjusted rate		7%	44%
Advanced therapy naive (N)	N=22	N=19	N=19
Response rate	23%	47%	47%
Placebo-adjusted rate		25%	25%

Advanced therapy experience includes prior exposure to approved biologics, S1P receptor modulators and/or JAK inhibitors. Percentages may not add up due to rounding.

资料来源: 2025 ECCO, 国信证券经济研究所整理

图16: Duvakitug 在 UC 适应症的临床有效性数据 (第 14 周)

Table 2: Week 14 clinical remission rates (per modified Mayo score)

Clinical remission (modified Mayo score)	Placebo	Duvakitug 450 mg	Duvakitug 900 mg
Total population (N)	N=44	N=47	N=46
Remission rate	20%	36%	48%
Placebo-adjusted rate		16%	27%
Advanced therapy experienced (N)	N=15	N=14	N=14
Remission rate	7%	29%	36%
Placebo-adjusted rate		22%	29%
Advanced therapy naive (N)	N=29	N=33	N=32
Remission rate	28%	39%	53%
Placebo-adjusted rate		12%	26%

Advanced therapy experience includes prior exposure to approved biologics, S1P receptor modulators and/or JAK inhibitors. Percentages may not add up due to rounding.

资料来源: 2025 ECCO, 国信证券经济研究所整理

自 2023 年起海外 MNC 公司开始布局 TL1A 靶点在 IBD 中的研发, 默沙东率先布局, 出资 108 美元收购 Prometheus 公司获得 Tulisokibart 管线, 收购以来从临床 2 期推进至临床 3 期阶段; 赛诺菲紧随其后, 以首付款 5 亿美元、里程碑付款 10 亿美元的金額与 Teva 达成商业化合作, 共同开发 Duvakitug 管线, 该管线已经完成临床 2 期患者入组; 罗氏以 71 亿美元首付款、1.5 亿美元短期里程碑付款获得 Telavant 的 RVT-3101 管线美国和日本的权益, 目前已经推进至临床 3 期阶段。

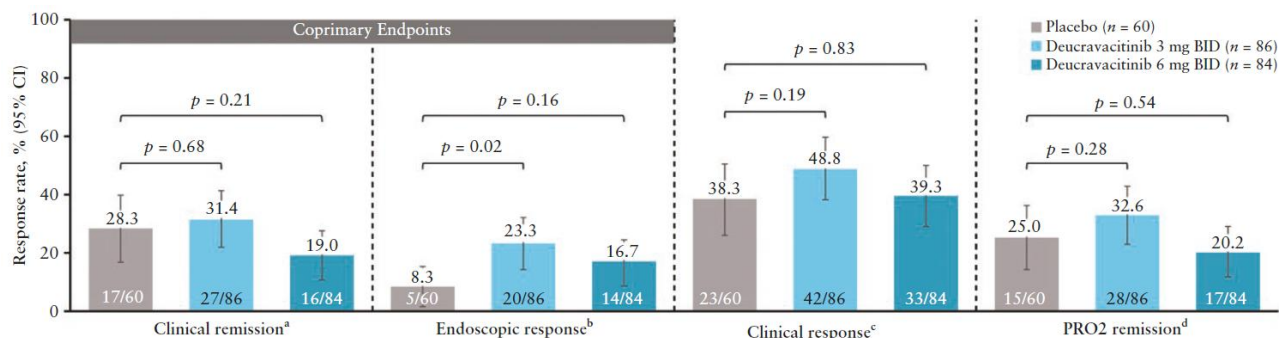
表3: TL1A 靶点分子商业化合作交易梳理

时间	项目	靶点	受让方	转让方	权利范围	交易金额	交易时临床阶段	现临床阶段
2023-04-16	Tulisokibart	TL1A	MSD	Prometheus	收购	108 亿美元收购公司	ph2	ph3
2023-10-04	Duvakitug	TL1A	Sanofi	Teva	合作开发	4.69 亿欧元 (5 亿美元) 首付款, 9.4 亿欧元 (10 亿美元) 里程碑付款	ph2b	ph2
2023-10-23	RVT-3101	TL1A	Roche	Telavant	美国, 日本	71 亿美元首付款, 1.5 亿美元短期里程碑付款	ph2b	ph3

资料来源: 公司官网, Insight, 国信证券经济研究所整理

Deucravacitinib 为 BMS 研发的 TYK2 抑制剂, 用于治疗 IBD 适应症, 临床 2/3 期的数据于 2025 年发表在国际期刊上。LATTICE-CD 研究针对 CD 适应症入组 239 名患者, 2:3:3 随机分为安慰剂组、3 mg、6 mg Deucravacitinib 治疗组, 每两天口服给药一次, 治疗 12 周出现临床响应后, 进入 6 mg Deucravacitinib (BID) 的维持治疗, 第 12 周有效性数据显示, 对照组 (n=60)、3 mg (n=86) 和 6 mg (n=84) 治疗组的临床缓解率分别为 28.3% vs 31.4% vs 19.0%, 内镜响应率分别为 8.3% vs 23.3% vs 16.7%, 均未达到显著性差异。

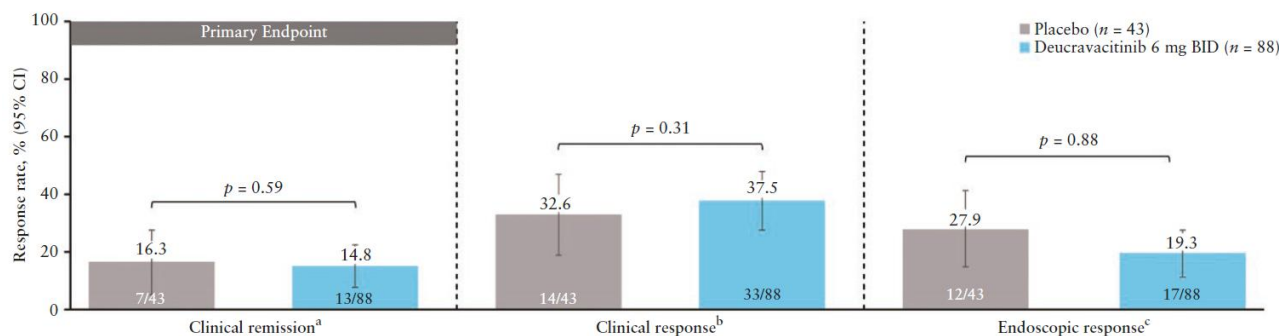
图17: Deucravacitinib 治疗 CD 适应症的临床有效性数据 (LATTICE-CD 研究, 第 12 周)



资料来源: Geert D' Haens, Silvio Danese et.al, Deucravacitinib in patients with inflammatory bowel disease: 12-week efficacy and safety results from 3 randomized phase 2 studies in Crohn's disease and ulcerative colitis, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 19, Issue 6, June 2025, jjaf080, 国信证券经济研究所整理

LATTICE-UC 研究针对 UC 适应症入组 228 名患者, 随机分为对照组和 6 mg Deucravacitinib 治疗组, 每两天口服给药一次, 第 12 周有效性数据显示, 对照组 (n=43) 和 6 mg (n=88) 治疗组的临床缓解率分别为 16.3% vs 14.8%, 临床响应率分别为 32.6% vs 37.5%, 内镜响应率分别为 27.9% vs 19.3%, 未达到显著性差异。

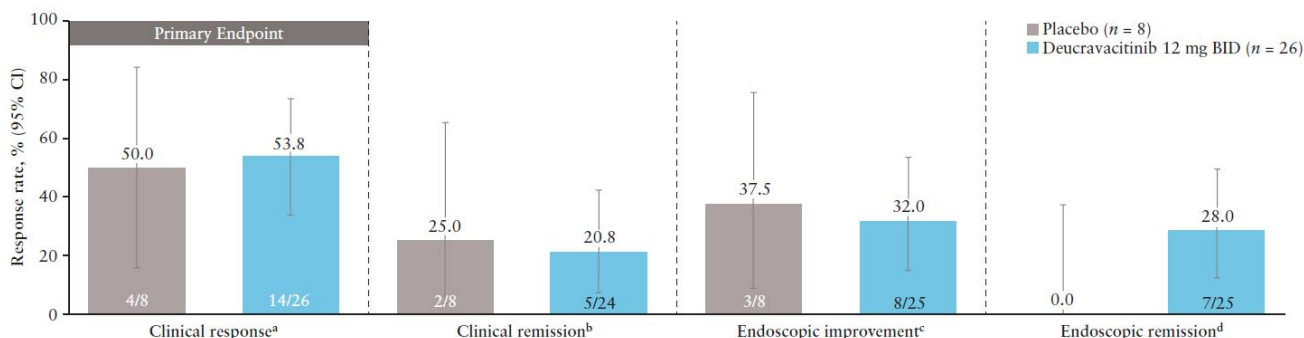
图18: Deucravacitinib 治疗 UC 适应症的临床有效性数据 (LATTICE-UC 研究, 第 12 周)



资料来源: Geert D' Haens, Silvio Danese et.al, Deucravacitinib in patients with inflammatory bowel disease: 12-week efficacy and safety results from 3 randomized phase 2 studies in Crohn's disease and ulcerative colitis, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 19, Issue 6, June 2025, jjaf080, 国信证券经济研究所整理

IM011-127 临床研究在 UC 适应症中探索更高剂量 12 mg Deucravacitinib 治疗, 对照组 (n=8) 和 6 mg (n=26) 治疗组的临床缓解率分别为 25.0% vs 20.8%, 临床响应率分别为 50.0% vs 53.8%, 未达到显著性差异。

图19: Deucravacitinib 治疗 UC 适应症的临床有效性数据 (IM011-127 研究, 第 12 周)



资料来源: Geert D' Haens, Silvio Danese et.al, Deucravacitinib in patients with inflammatory bowel disease: 12-week efficacy and safety results from 3 randomized phase 2 studies in Crohn's disease and ulcerative colitis, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 19, Issue 6, June 2025, jja080, 国信证券经济研究所整理

Zasocitinib 为武田研发的一款 TYK2 抑制剂, 针对 UC 和 CD 开展临床 2 期研究。针对 UC 适应症的 TAK-279-UC-2001 研究计划入组 207 名患者, 设置对照组和两个剂量的治疗组, 接受 12 周诱导期治疗, 出现临床响应的患者随后进入维持期治疗, 观察第 52 周的有效性和安全性数据, 2024 年 3 月 29 日临床完成首例受试者入组; 针对 CD 适应症, 计划入组 268 名患者, 设置对照组和三个剂量的治疗组, 同样接受诱导期治疗 (12 周) 和维持期治疗, 观察第 52 周的有效性和安全性数据, 2024 年 3 月 5 日完成首例受试者入组。

在 IBD 适应症中, 国内药企 TYK2 和 TL1A 靶点的药物研发仍处于早期阶段, 整体竞争格局良好。TYK2 靶点中, 进展最快的是益方生物的 D-2570, 2025 年 5 月针对 UC 在国内开展临床 2 期研究, 正大天晴的 TQH3906 进度第二, 针对 UC 和 CD 适应症在国内开展临床 1 期研究, 2025 年 1 月完成首例受试者入组, 祐森健恒的 UA021、凌科药业的 LNK01009 分别处于海外 IND 和 pre-IND 阶段。TL1A 靶点中, 三生制药的 SSGJ-627 进度最快, 针对 UC 适应症在国内开展临床 1 期研究, 海外临床处于 pre-IND 阶段, 明济生物的 FG-M701 在美国开展 ph1, 华深智药的 HXN-1002 在美国处于 pre-IND 阶段。

表4: TYK2 和 TL1A 靶点药物在 IBD 适应症中的竞争格局

公司	药品	靶点	适应症	国内	国外	FPI	临床编号
益方生物	D-2570	TYK2	溃疡性结肠炎	ph2	-		CTR20251691
正大天晴	TQH3906	TYK2	溃疡性结肠炎, 克罗恩病	ph1	-	2025-01-28	NCT06754891
祐森健恒	UA021	TYK2	炎症性肠病	-	IND		
凌科药业	LNK01009	TYK2	炎症性肠病	-	pre-IND		
三生制药	SSGJ-627	TL1A	溃疡性结肠炎	ph1	pre-IND		CTR20251372
明济生物	FG-M701	TL1A	炎症性肠病	-	ph1		NCT06895343
华深智药	HXN-1002	TL1A	炎症性肠病	-	pre-IND		

资料来源: Insight, 国信证券经济研究所整理

艾伯维: Risankizumab (IL-23p19 抗体)

利生奇珠单抗 (Risankizumab, 商品名: 喜开悦) 是艾伯维研发的一款 IL-23p19 抗体, 于 2025 年 3 月 10 日获得国家药品监督管理局 (NMPA) 批准, 用于治疗成人中重度活动期克罗恩病患者 (CD)。在 CD-1 和 CD-2 两项临床中, 入组患者的中位 CDAI 均为 307, 中位 SES-CD 分别为 12 和 13, CD-1 组 58% 的患者曾接受过生物制剂治疗, CD-2 组患者全部接受过生物制剂治疗。治疗方案为, 在第 0、4 和 8

周静脉给与 Risankizumab (600 mg 或 1200 mg) 或安慰剂治疗, 临床出现响应的患者进入到维持阶段临床研究, 每 8 周一次皮下给与 Risankizumab (180 mg 或 360 mg) 和不再给药治疗 (对照组) 到 52 周。

CD-1 临床的诱导期研究的第 12 周数据显示, 600 mg 治疗组 (n=336) 和对照组 (n=175) 比较, 临床缓解率分别为 45% vs 25%, 临床响应率分别为 60% vs 37%, 内镜响应率分别为 40% vs 12%, 内镜缓解率分别为 24% vs 9%。CD-2 临床数据显示, 600 mg 治疗组 (n=191) 和对照组 (n=187) 比较, 临床缓解率分别为 42% vs 20%, 临床响应率分别为 60% vs 30%, 内镜响应率分别为 29% vs 11%, 内镜缓解率分别为 19% vs 4%。进入维持治疗阶段后, 第 52 周数据显示, 360 mg (n=117)、180 mg (n=135) 和对照组 (n=130) 的临床缓解率为 57% vs 61% vs 46%, 临床响应率为 48% vs 50% vs 48%。

图20: Risankizumab 治疗 CD 适应症的 CD-1 临床有效性数据 (第 12 周)

Endpoint	Placebo	SKYRIZI 600 mg Intravenous Infusion ^a	Treatment Difference ^b (95% CI)
Clinical Remission ^{c,d}			
Total Population	N=175 25%	N=336 45%	21% ^e (12%, 29%)
Prior biologic failure ^f	N=97 26%	N=195 42%	
Without prior biologic failure	N=78 23%	N=141 49%	
Endoscopic Response ^{c,g}			
Total Population	N=175 12%	N=336 40%	28% ^e (21%, 35%)
Prior biologic failure ^f	N=97 11%	N=195 33%	
Without prior biologic failure	N=78 13%	N=141 50%	
Clinical Response ^h			
Total Population	N=175 37%	N=336 60%	23% ^e (14%, 32%)
Prior biologic failure ^f	N=97 34%	N=195 58%	
Without prior biologic failure	N=78 40%	N=141 62%	
Endoscopic Remission ⁱ			
Total Population	N=175 9%	N=336 24%	15% ^e (9%, 21%)
Prior biologic failure ^f	N=97 5%	N=195 18%	
Without prior biologic failure	N=78 14%	N=141 32%	

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

图21: Risankizumab 治疗 CD 的 CD-2 临床数据 (第 12 周)

Endpoint	Placebo N=187	SKYRIZI 600 mg Intravenous Infusion ^b N=191	Treatment Difference ^c (95% CI)
Clinical Remission ^{a,e}	20%	42%	22% ^f (13%, 31%)
Endoscopic Response ^{a,g}	11%	29%	18% ^f (10%, 25%)
Clinical Response ^h	30%	60%	29% ^f (20%, 39%)
Endoscopic Remission ⁱ	4%	19%	15% ^f (9%, 21%)

a. All subjects enrolled in CD-2 had prior biologic failure. Prior biologic failure includes inadequate response, loss of response, or intolerance to one or more biologic treatments for CD.
 b. SKYRIZI 600 mg as an intravenous infusion at Week 0, Week 4, and Week 8.
 c. Adjusted treatment difference (95% CI) based on Cochran-Mantel-Haenszel method adjusted for randomization stratification factors.
 d. Co-primary endpoints.
 e. CDAI score <150.
 f. p < 0.001.
 g. A decrease in SES-CD > 50% from baseline, or a decrease of at least 2 points for subjects with a baseline score of 4 and isolated ileal disease, based on central reading.
 h. A reduction of CDAI ≥ 100 points from baseline.
 i. SES-CD < 4 and at least a 2-point reduction versus from baseline, with and no individual subscore greater than 1, based on central reading.

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

图22: Risankizumab 治疗 CD 的 CD-3 临床数据 (第 52 周)

Endpoint	Placebo ^a	SKYRIZI 180 mg Subcutaneous Injection ^b	SKYRIZI 360 mg Subcutaneous Injection ^c	Treatment Difference vs Placebo ^d (95% CI)	
				SKYRIZI 180 mg	SKYRIZI 360 mg
Clinical Remission^{e,f}					
Total Population	N=130 46%	N=135 61%	N=117 57%	17% ^g (6%, 28%)	14% ^g (3%, 26%)
Prior biologic failure ^h	N=99 40%	N=95 56%	N=83 51%		
Without prior biologic failure	N=31 65%	N=40 75%	N=34 71%		
Endoscopic Response^{e,f}					
Total Population	N=130 22%	N=135 50%	N=117 48%	30% ^g (20%, 39%)	31% ^g (21%, 41%)
Prior biologic failure ^h	N=99 21%	N=95 44%	N=83 44%		
Without prior biologic failure	N=31 23%	N=40 65%	N=34 59%		

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

UC 适应症的 UC-1 临床共入组 966 名中重度活动期 UC 患者, 患者的中位修饰后的 mayo 评分为 7, 52% 的患者 (n=499) 接受过 1 种或多种生物制剂治疗, 其中 97% 患者生物制剂治疗失败, 18% 的患者 JAK 抑制剂治疗失败。治疗方案为, 在第 0、4 和 8 周静脉给与 1200 mg Risankizumab 和安慰剂治疗, 12 周后进入维持期治疗。维持期的治疗方案为皮下注射 180/360 mg Risankizumab (Q8W), 观察第 52 周的临床数据。第 12 周数据显示, Risankizumab 治疗组 (n=646) 和对照组 (n=320) 的临床缓解率分别为 24% vs 8%, 临床响应率分别为 65% vs 36%, 内镜改善率为 36% vs 12%, 组织学内镜黏膜改善率分别为 24% vs 7%。

图23: Risankizumab 治疗 UC 适应症的 UC-1 临床有效性数据 (第 12 周)

Endpoint	Placebo	SKYRIZI 1,200 mg Intravenous Infusion ^a	Treatment Difference (95% CI) ^b
Clinical Remission^c			
Total Population	N=320 8%	N=646 24%	16% ^b (12%, 20%)
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^d	N=168 6%	N=331 14%	
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=152 9%	N=315 33%	
Clinical Response^e			
Total Population	N=320 36%	N=646 65%	29% ^b (23%, 35%)
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^d	N=168 32%	N=331 56%	
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=152 41%	N=315 75%	
Endoscopic Improvement^f			
Total Population	N=320 12%	N=646 36%	25% ^b (20%, 30%)
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^d	N=168 10%	N=331 26%	
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=152 14%	N=315 47%	
Histologic Endoscopic Mucosal Improvement (HEMI)^g			
Total Population	N=320 7%	N=646 24%	17% ^b (13%, 21%)
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^d	N=168 7%	N=331 16%	
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=152 8%	N=315 33%	

资料来源: 药品说明书, 国信证券经济研究所整理

维持阶段的数据显示，360 mg (n=186)、180 mg (n=179) 和对照组 (n=182) 的临床缓解率分别为 41% vs 45% vs 26%，内镜改善率分别为 48% vs 51% vs 31%，组织学黏膜内镜改善率分别为 42% vs 43% vs 24%。

图24: Risankizumab 治疗 UC 适应症的 UC-2 临床有效性数据 (第 52 周)

Endpoint	Placebo ^a	SKYRIZI 180 mg SC Injection ^b	SKYRIZI 360 mg SC Injection ^c
Clinical remission ^d			
Total Population	N=182 26%	N=179 45%	N=186 41%
Treatment Difference vs Placebo ^e (95% CI)		20% ^j [11%, 29%]	16% ^j [7%, 25%]
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^f	N=138 24%	N=134 41%	N=139 32%
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=44 32%	N=45 58%	N=47 67%
Corticosteroid-free clinical remission ^g			
Total Population	N=182 26%	N=179 45%	N=186 40%
Treatment Difference vs Placebo ^e (95% CI)		20% ^j [11%, 29%]	16% ^j [7%, 25%]
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^f	N=138 24%	N=134 40%	N=139 32%
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=44 32%	N=45 58%	N=47 64%
Endoscopic improvement ^h			
Total Population	N=182 31%	N=179 51%	N=186 48%
Treatment Difference vs Placebo ^e (95% CI)		20% ^j [11%, 30%]	18% ^j [8%, 27%]
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^f	N=138 30%	N=134 48%	N=139 39%
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=44 34%	N=45 60%	N=47 76%
Histologic Endoscopic Mucosal Improvement ⁱ			
Total Population	N=182 24%	N=179 43%	N=186 42%
Treatment Difference vs Placebo ^e (95% CI)		20% ^j [11%, 29%]	20% ^j [11%, 29%]
Prior biologic, JAKi, or S1PRM failure ^f	N=138 22%	N=134 39%	N=139 33%
Without prior biologic, JAKi, or S1PRM failure	N=44 30%	N=45 55%	N=47 69%

资料来源：药品说明书，国信证券经济研究所整理

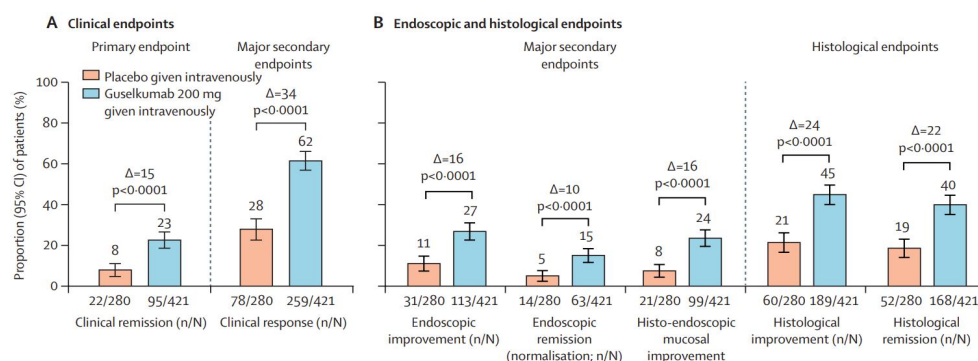
强生：Guselkumab (IL-23p19 抗体)

Guselkumab 是强生开发的一款 IL-23p19 抗体，在美国已经获批用于中重度斑块状银屑病、银屑病关节炎和中重度活动期 UC，中重度活动期 CD 适应症申请已经获得 FDA 受理，在中国获批用于治疗银屑病和成人中重度 CD 适应症。Guselkumab

针对中重度活动期 UC 开展临床 3 期研究（QUASAR 研究），入组患者诱导期治疗基线的修正 Mayo 评分为 5-9, 均为对传统治疗或新型疗法不响应或不耐受的患者，3:2 随机分为 Guselkumab（200 mg）治疗组和安慰剂组，在诱导期第 0、4、8 周静脉给药治疗。治疗 12 周，有临床响应的患者进入到维持期治疗，分别在维持期的第 0 周开始，给与 200 mg Guselkumab（Q4W）、100mg Guselkumab（Q8W）或对照组（不再给药）治疗。

诱导期治疗阶段，共有 701 名患者入组，第 12 周数据显示，Guselkumab 相比于安慰剂组展示出更好的临床缓解率 23%（n=421）vs 8%（n=280），临床响应率分别为 62% vs 28%，内镜改善率分别为 27% vs 11%，内镜缓解率分别为 15% vs 5%。

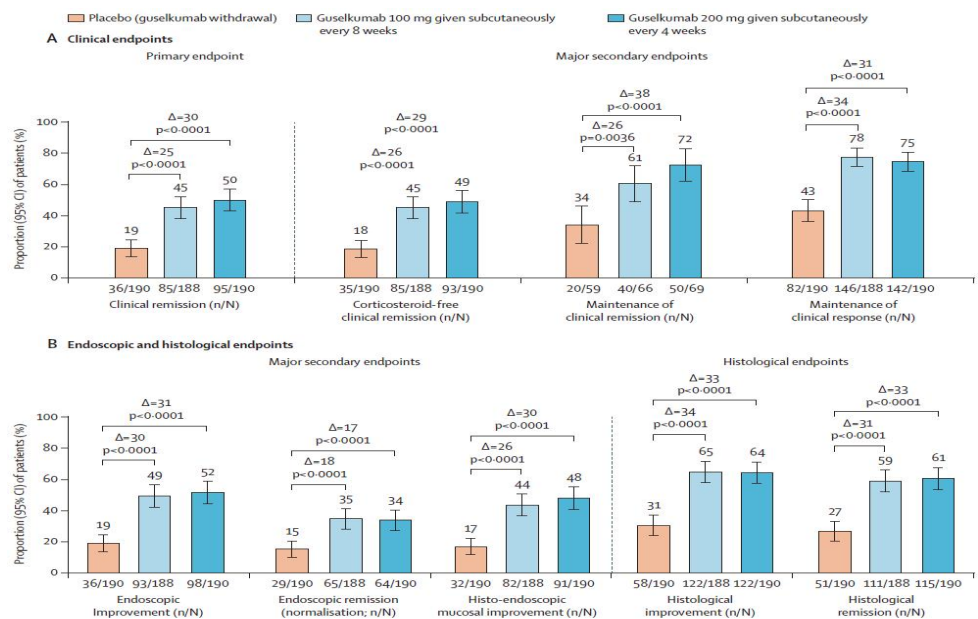
图25: Guselkumab 治疗 UC 适应症的临床 III 期研究数据（第 12 周）



资料来源: Rubin DT, Allegretti JR et. al, QUASAR Study Group. Guselkumab in patients with moderately to severely active ulcerative colitis (QUASAR): phase 3 double-blind, randomised, placebo-controlled induction and maintenance studies. Lancet. 2025 Jan 4;405(10472):33-49, 国信证券经济研究所整理

维持期治疗阶段，共有 568 名患者入组，维持期的第 44 周数据显示，100 mg 和 200 mg 剂量 Guselkumab 皮下给药相比于对照组（不再给药）获得更好的临床效果，主要终点临床缓解率分别为 50%（200 mg, n=190）vs 45%（100 mg, n=188）vs 19%（对照组, n=190），内镜改善率分别为 52% vs 49% vs 19%，内镜缓解率分别为 35% vs 34% vs 15%。

图26: Guselkumab 治疗 UC 适应症的临床 III 期研究数据（维持期第 44 周）



资料来源: Rubin DT, Allegretti JR et. al, QUASAR Study Group. Guselkumab in patients with moderately to severely active ulcerative colitis (QUASAR): phase 3 double-blind, randomised, placebo-controlled induction and maintenance studies. Lancet. 2025 Jan 4;405(10472):33-49, 国信证券经济研究所整理

炎症性肠病为一种慢性反复发作的肠道炎症性疾病，现有的生物制剂和小分子药物仍存在一定的局限性，即表现为药物低至中度的临床缓解率和更低的黏膜愈合率，部分药物在先前使用过生物制剂的患者中治疗效果下降，甚至随着治疗时间延长，出现无应答的情况，安全性方面仍面临长期用药会出现的免疫抑制的情况。IBD 治疗出现多个创新型的靶点，包括 TYK2 小分子、IL-23 抗体和 TL1A 抗体，临床数据显示出初步的临床响应率，多个 MNC 药企通过 BD 或者自研的方式纷纷布局 IBD 领域，有望进一步推动 IBD 领域新药研发进展，建议持续关注 IBD 领域的研发进展和布局该领域的相关公司：三生国健、益方生物、诺诚健华。

表5: CD 适应症中 IL-23 和 TL1A 抗体的临床数据对比

通用名	利生奇珠单抗				古塞奇尤单抗		Tulisokibart/PRA023		Duvakitug		
研发企业	艾伯维				强生		Prometheus/Merck		Sanofi/Teva		
靶点	IL-23				IL-23		TL1A		TL1A		
临床数据阶段	ph3				ph3		ph2a		ph2b		
给药程序	600mg/1200mg IV 第 0/4/8 周, 180mg/360mg SC Q8W				SC 第 0/4/8 周		首次 1000mg IV, 第 2/6/10 周 500mg IV		首次 2250mg SC, 后面 Q2W		
剂量组	PB0	600mg	PB0	600mg	PB0	400mg	PB0	Tulisokibart	PB0	450mg	900mg
患者人数	n=175	n=336	n=187	n=191	n=117	n=230	n=67	n=68	n=46	n=46	n=46
患者基线											
disease duration, year, mean (SD)	307								9.6	11.5	11.3
CDAI score, mean (SD)	12								309.4	304.7	294.1
SES-CD, mean (SD)									12	12.7	12.3
治疗背景	58%接受过生物制剂治疗 所有患者接受过生物制剂治疗										
induction (12w)											
Clinical Remission	25%	45%	20%	42%	21.4%	56.1%	16%	49%			
Clinical Response	37%	60%	30%	60%							
Endoscopic Response	12%	40%	11%	29%	21.4%	41.3%			13%	26%	48%
Endoscopic Remission	9%	24%	4%	19%			12%	26%			

maintenance (52w)						
患者人数		n=130	n=135	n=117		
Clinical Remission		46%	61%	57%		
Clinical Response		22%	50%	48%		
Endoscopic Remission						
Endoscopic Response						
数据来源		药品说明书		2025 ECCO	2025 ECCO	2025 ECCO

资料来源：2025 ECCO，药品说明书，国信证券经济研究所整理 注：PBO 为对照组，IV 为静脉给药，SC 为皮下注射

表6: UC 适应症中 IL-23 和 TL1A 抗体的临床数据对比

通用名	古塞奇尤单抗		Icotoxinra		利生奇珠单抗		Tulisokibart /PRA023		RVT-3101 (R07790121)				Duvakitug		
研发企业	强生		强生		艾伯维		Prometheus/Merck		Roche				Sanofi/Teva		
靶点	IL-23		IL-23R		IL-23		TL1A		TL1A				TL1A		
临床数据阶段	ph3		ph2b		ph2/3		ph2		ph2b				ph2b		
剂量程序	200mg IV 第 0/4/8 周, 200mg SC Q4W 或 100mg SC Q8W		Oral QD		1200mg IV 0/4/8w, 180/360mg SC Q8W		首次 1000mg, 第 2/6/10 周 500mg IV		50/150/450mg SC				首次 2250mg SC, 后面 450mg/900mg Q2W		
剂量组	PBO 200mg		PBO Icotrokinra				PBO Tulisokibart		PBO 50mg 150mg 450mg				PBO 450mg 900mg		
患者人数	n=280 n=421		n=252		n=320 n=646		n=67 n=68						n=44 n=47 n=46		
患者基线															
disease duration					7		6.3 6.7						6.2 9 7.8		
Modified Mayo scale							7.1 6.9						6.8 6.6 6.8		
Endoscopic subscore							79% 68%								
治疗背景							~50%使用过生物制剂或 JAK 抑制剂								
induction (12/14w)															
Clinical Remission	8%	23%	11.1%	30.2%	8%	24%	1%	26%	12%	40%	40%	33%	20%	36%	48%
Clinical Response	28%	62%	27.0%	63.5%	36%	65%	22%	66%	5%	35%	36%	31%			
Endoscopic Improvement	11%	27%			12%	36%	6%	37%	5%	30%	32%	26%			
Endoscopic Remission	5%	15%							5%	28%	28%	23%			
Mucosal Healing					7%	24%	4%	31%							
maintenance (52/56w)	PBO	100mg 200mg			n=182 n=179 n=186										
Clinical Remission	19%	45% 50%			26% 45% 41%				-	37	25	26			
Clinical Response	43%	78% 75%							-	32%	40%	23%			
Endoscopic Improvement	19%	49% 52%			31% 51% 48%				-	41%	48%	31%			
Endoscopic Remission	15%	35% 34%							-	27%	40%	23%			
Mucosal Healing					24% 43% 42%				-	24%	32%	19%			
数据来源	DOI: 0.1016/S0140-Protagonist 6736 (24) 01927-5.		交流资料		药品说明书		DOI: 0.1056/NEJ Moa2314076		2025 ECCO				2025 ECCO		

资料来源：2025 ECCO，药品说明书，参考文献，国信证券经济研究所整理 注：PBO 为对照，IV 为静脉给药，SC 为皮下注射

本周行情回顾

本周全部 A 股上涨 1.42%（总市值加权平均），沪深 300 上涨 0.88%，中小板指上涨 1.62%，创业板指上涨 2.32%，生物医药板块整体上涨 1.13%，生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨 1.67%，生物制品上涨 1.00%，医疗服务上涨 0.73%，医疗器械上涨 1.11%，医药商业上涨 1.13%，中药上涨 0.39%。

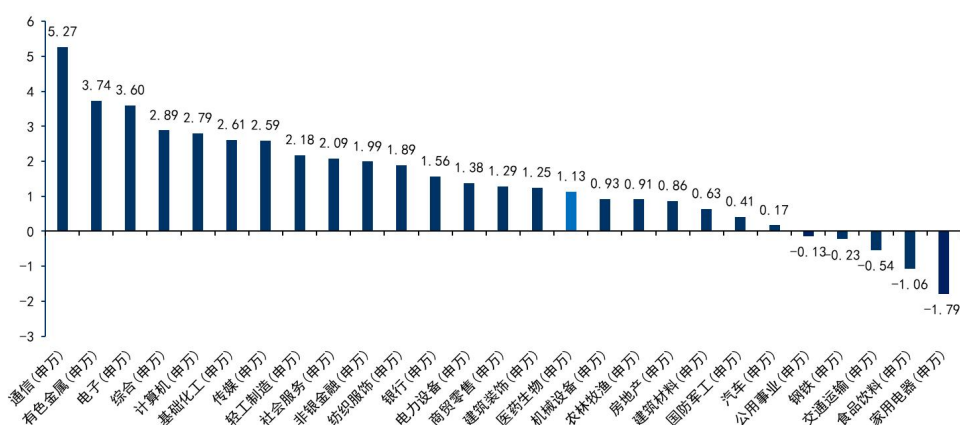
个股方面，涨幅居前的是易明医药（33.09%）、万邦德（32.59%）、昂利康（30.28%）、新诺威（21.36%）、海辰药业（20.93%）、赛伦生物（20.42%）、迈威生物-U（17.72%）、神州细胞（17.24%）、常山药业（16.10%）、微芯生物（15.66%）。

跌幅居前的是龙津退（-36.28%）、瑞普生物（-14.40%）、华森制药（-12.36%）、迈普医学（-9.29%）、*ST 苏吴（-7.35%）、海翔药业（-7.26%）、河化股份（-6.67%）、森萱医药（-6.66%）、数字人（-6.60%）、海思科（-6.11%）。

本周恒生指数上涨 2.16%，港股医疗保健板块上涨 4.09%，板块相对表现强于恒生指数。分子板块来看，制药板块上涨 2.29%，生物科技上涨 4.89%，医疗保健设备上涨 2.47%，医疗服务上涨 0.78%。

市场表现居前的是（仅统计市值 50 亿港币以上）健康之路（51.46%）、再鼎医药（23.28%）、信达生物（18.08%）、同源康医药-B（17.91%）、绿叶制药（16.67%）；跌幅居前的是巨子生物（-16.90%）、和铂医药-B（-10.86%）、康宁杰瑞制药-B（-10.75%）、心泰医疗（-10.26%）、康基医疗（-8.35%）。

图27：申万一级行业一周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

表7: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况

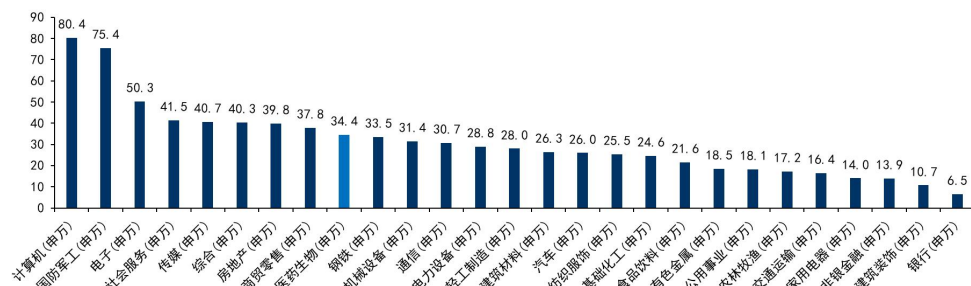
本周涨幅前十		本周跌幅前十	
股票简称	涨幅	股票简称	跌幅
易明医药	33.09%	龙津退	-36.28%
万邦德	32.59%	瑞普生物	-14.40%
昂利康	30.28%	华森制药	-12.36%
新诺威	21.36%	迈普医学	-9.29%
海辰药业	20.93%	*ST 苏吴	-7.35%
赛伦生物	20.42%	海翔药业	-7.26%
迈威生物-U	17.72%	河化股份	-6.67%
神州细胞	17.24%	森萱医药	-6.66%
常山药业	16.10%	数字人	-6.60%
微芯生物	15.66%	海思科	-6.11%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 注: 本表仅做列示, 不做推荐

板块估值情况

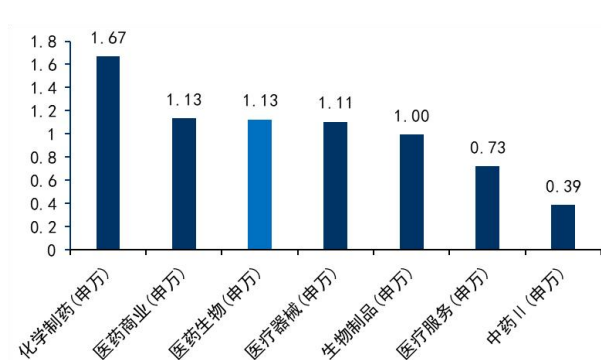
医药生物市盈率（TTM）34.41x，全部 A 股（申万 A 股指数）市盈率 18.62x。分板块来看，化学制药 41.96x，生物制品 41.19x，医疗服务 30.29x，医疗器械 34.47x，医药商业 20.39x，中药 27.78x。

图28: 申万一级行业市盈率情况（TTM）



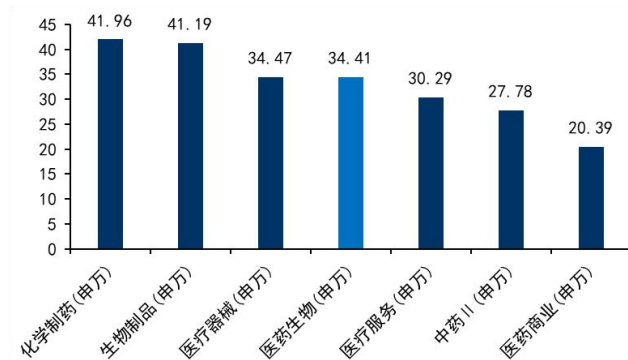
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图29: 医药行业子板块一周涨跌幅（%）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图30: 医药行业子板块市盈率情况（TTM）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

推荐标的

迈瑞医疗：公司作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著。公司受益于国内医疗新基建和产品迭代升级，并在海外加快高端客户拓展。微创外科、心血管等种子业务高速放量，“三瑞”数智化方案引领转型升级。

药明康德：公司是行业中极少数在新药研发全产业链均具备服务能力的开放式新药研发服务平台，有望全面受益于全球新药研发外包服务市场的快速发展。公司“一体化、端到端”的新药研发服务平台，无论是在服务的技术深度还是覆盖广度方面都能满足客户提出的多元化需求。

新产业：公司为化学发光免疫分析领域的龙头，拥有技术、生产和销售等方面的多重优势，坚实庞大的装机基础未来将持续带动试剂销售，促进进口替代，同时国际化和平台化布局将开启新成长曲线。

惠泰医疗：公司专注电生理和介入类医疗器械研发、生产及销售，在相关领域品种齐全、规模领先。已上市产品涵盖电生理、冠脉通路、外周血管介入及非血管介入医疗器械。2024 年迈瑞医疗完成对公司的控制权收购，成为实际控制人，凭借迈瑞在医疗器械领域的行业地位及丰富经验，公司有望实现海内外市场拓展及产品研发等方面的全方位赋能，巩固在心血管领域的领先地位。

开立医疗：开立医疗是国内“超声+软镜”行业领军企业，持续丰富业务矩阵，公司超声业务已经历 20 多年发展，建立了较为完善的营销网络渠道，超声行业也逐步进入成熟期。作为国产软镜后起之秀，开立在国内市场已跻身市占率第三。同时持续布局微创外科和心血管介入，新业务成长可期。

澳华内镜：公司为国产软镜设备龙头，软镜市场国产化率提升空间巨大，公司旗舰产品 AQ-300 于 2022 年底上市，性能媲美进口产品，目前市场推广进展顺利，有望带动收入高增长和盈利能力提升。

艾德生物：公司是肿瘤精准诊断领域的龙头企业，产品线布局领先，构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，在院内渠道具备强大的销售壁垒；此外，公司产品顺利出海，中长期发展空间广阔。

爱博医疗：公司是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家，且在中国境内第 2 家取得角膜塑形镜注册证，隐形眼镜正处于快速放量阶段。公司拥有丰富在研管线，未来平台化和国际化发展潜力大。

金域医学：公司基于高强度的自主研发和产学研一体化，每年推出数百项创新项目，高端技术平台的不断完善和“医检 4.0”数字化转型战略落地将驱动公司盈利能力稳健提升。

康方生物(9926.HK)：公司为专注创新的双抗龙头，在研管线丰富，双抗、ADC、单抗等不同分子形态已形成梯队。依沃西持续验证 FIC & BIC 潜力，公司与 Summit 合作持续推进全球的临床。卡度尼利与依沃西已经成功实现了国内的商业化，有望成为重磅品种。

科伦博泰生物-B(6990.HK)：公司 ADC 产品早期临床数据优秀，研发进度在全球范围内较为领先，且已经与默沙东达成了深度的合作，有利于产品实现在全球的商业化潜力。公司未来 2~3 年的营收主要来源于默沙东的首付款和里程碑付款，产品销售将在 2025 年后开始放量。

和黄医药(0013.HK)：公司是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，专注

于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。呋喹替尼 2023 年底在美国获批上市后迅速放量，赛沃替尼也有望向 FDA 递交上市申请，索乐匹尼布临床数据优秀，预计将于 2025 年获批上市。

康诺亚-B(2162.HK)：公司的司普奇拜单抗是首个获批上市的国产 IL4R 单抗，季节性过敏性鼻炎适应症是司普奇拜单抗获批的第三个适应症，此前，成人中重度特应性皮炎适应症和慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症分别于 2024 年 9 月和 2024 年 12 月获批上市，三个适应症均有可能通过 2025 年的国谈进入医保。

三生制药(01530.HK)：公司是一家集研发、生产和销售为一体的生物制药领军企业，在肾科、皮肤科、自身免疫科、肿瘤科的药物有多年的研发、销售经验。

爱康医疗(1789.HK)：公司是中国第一家将 3D 打印技术商业化的人工关节领域龙头公司，公司产品线齐全，借助集采提升市场份额，加速进口替代，巩固龙头地位。骨生物材料和数字化骨科将成为新增长点。

风险提示

研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

附表：重点覆盖公司盈利预测及估值

代码	公司简称	子行业	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE				ROE		PEG	投资 评级
				24A	25E	26E	27E	24A	25E	26E	27E	24A	25E		
300760.SZ	迈瑞医疗	医疗器械	2,819	116.7	124.1	141.0	161.9	24.2	22.7	20.0	17.4	32.5%	2.0	2.0	优于大市
300832.SZ	新产业	医疗器械	495	18.3	20.4	24.3	28.8	27.1	24.3	20.3	17.2	21.3%	1.5	1.5	优于大市
688212.SH	澳华内镜	医疗器械	75	0.2	0.5	1.0	1.2	358.1	139.4	76.8	60.7	1.5%	1.7	1.7	优于大市
688161.SH	威高骨科	医疗器械	106	2.2	2.5	3.1	3.8	47.2	41.6	33.8	28.0	5.7%	2.2	2.2	优于大市
688271.SH	联影医疗	医疗器械	1,106	12.6	17.0	20.8	23.3	87.6	64.9	53.2	47.5	6.3%	2.9	2.9	优于大市
688050.SH	爱博医疗	医疗器械	137	3.9	4.7	5.8	7.2	35.3	29.3	23.7	19.1	16.1%	1.3	1.3	优于大市
301363.SZ	美好医疗	医疗器械	97	3.6	4.6	5.7	6.9	26.7	20.9	17.1	14.0	10.5%	0.9	0.9	优于大市
688236.SH	春立医疗	医疗器械	58	1.2	2.2	2.7	3.3	46.5	26.2	21.3	17.6	4.4%	0.7	0.7	优于大市
300049.SZ	福瑞股份	医疗器械	91	1.1	2.1	2.8	3.6	80.0	43.8	32.4	25.1	6.5%	0.9	0.9	优于大市
300463.SZ	迈克生物	医疗器械	73	1.3	2.7	3.5	4.2	57.7	26.8	20.7	17.3	2.0%	0.5	0.5	优于大市
300685.SZ	艾德生物	医疗器械	82	2.5	3.2	3.8	4.5	32.1	25.8	21.4	18.1	13.8%	1.2	1.2	优于大市
688358.SH	祥生医疗	医疗器械	33	1.4	1.7	2.0	2.3	23.7	19.6	17.0	14.8	9.9%	1.2	1.2	优于大市
688389.SH	普门科技	医疗器械	56	3.5	5.1	6.2	-	16.1	10.9	8.9	-	16.8%	0.3	0.3	优于大市
688029.SH	南微医学	医疗器械	124	5.5	6.9	8.0	8.9	22.4	18.0	15.5	14.0	14.5%	1.1	1.1	优于大市
603301.SH	振德医疗	医疗器械	56	3.9	3.9	5.0	5.7	14.4	14.2	11.2	9.7	6.8%	1.0	1.0	优于大市
688626.SH	翔宇医疗	医疗器械	62	1.0	1.4	1.8	2.2	60.7	44.3	35.5	28.9	5.0%	1.6	1.6	优于大市
605369.SH	拱东医疗	医疗器械	43	1.7	1.6	1.9	2.1	25.0	26.7	22.7	20.1	10.1%	3.5	3.5	优于大市
300633.SZ	开立医疗	医疗器械	142	1.4	3.1	4.0	4.8	99.4	45.2	35.7	29.3	4.6%	0.9	0.9	优于大市
688575.SH	亚辉龙	医疗器械	86	3.0	5.1	6.7	-	28.6	16.8	12.9	-	10.9%	0.3	0.3	优于大市
688617.SH	惠泰医疗	医疗器械	383	6.7	8.8	11.3	14.7	56.9	43.7	33.8	26.0	26.8%	1.5	1.5	优于大市
002653.SZ	海思科	化学制药	481	4.0	5.5	6.9	8.7	121.7	88.0	69.5	55.5	9.4%	2.9	2.9	优于大市
688062.SH	迈威生物-U	生物药	111	(10.4)	(5.2)	(1.3)	-	(10.7)	(21.6)	(88.5)	-	-66.5%	0.3	0.3	优于大市
300601.SZ	康泰生物	生物药	160	2.0	8.1	10.0	-	79.4	19.8	16.1	-	2.1%	0.2	0.2	优于大市
688687.SH	凯因科技	生物药	46	1.4	2.0	2.6	-	32.5	23.1	17.7	-	7.7%	0.6	0.6	优于大市
688319.SH	欧林生物	生物药	72	0.2	0.7	1.3	-	348.1	111.2	54.3	-	2.2%	0.7	0.7	优于大市
688443.SH	智翔金泰-U	生物药	110	(8.0)	(6.7)	(4.4)	(0.5)	(13.9)	(16.5)	(25.1)	(235.0)	-37.5%	0.3	0.3	优于大市
688278.SH	特宝生物	生物药	300	8.3	10.7	15.4	21.7	36.2	28.0	19.5	13.8	32.4%	0.7	0.7	优于大市
000999.SZ	华润三九	中药	546	33.7	37.4	40.8	48.6	16.2	14.6	13.4	11.2	16.9%	1.1	1.1	优于大市
600557.SH	康缘药业	中药	78	3.9	6.1	6.8	-	19.9	12.8	11.5	-	8.7%	0.4	0.4	优于大市
600129.SH	太极集团	中药	116	0.3	13.0	15.6	-	435.6	8.9	7.4	-	0.8%	0.0	0.0	优于大市
688046.SH	药康生物	生命科学与工业上游	52	1.1	1.3	1.7	1.9	47.2	39.2	31.2	27.5	5.1%	2.0	2.0	优于大市
301080.SZ	百普赛斯	生命科学与工业上游	64	1.2	1.6	2.3	2.8	52.0	41.0	28.6	22.9	4.7%	1.3	1.3	优于大市
688293.SH	奥浦迈	生命科学与工业上游	47	0.2	0.8	1.1	1.5	222.2	60.0	41.8	30.6	1.0%	0.6	0.6	优于大市
603259.SH	药明康德	CXO	1,851	93.5	111.6	127.3	145.1	19.8	16.6	14.5	12.8	16.1%	1.1	1.1	优于大市
000739.SZ	普洛药业	CXO	166	10.3	11.2	12.6	14.0	16.1	14.8	13.2	11.9	15.3%	1.4	1.4	优于大市
603127.SH	昭衍新药	CXO	134	0.7	3.3	3.8	4.1	181.2	40.7	35.2	32.5	0.9%	0.5	0.5	优于大市
301096.SZ	百诚医药	CXO	47	(0.5)	0.5	0.9	1.2	(89.7)	89.2	55.0	40.8	-2.0%	-0.4	-0.4	优于大市
688076.SH	诺泰生物	CXO	113	4.0	5.8	7.9	11.0	27.9	19.5	14.2	10.3	15.2%	0.5	0.5	优于大市
688222.SH	成都先导	CXO	68	0.5	0.6	0.8	1.0	131.6	107.3	86.7	69.7	3.7%	4.5	4.5	优于大市
603882.SH	金城医学	医疗服务	139	(3.8)	6.9	8.5	-	(36.5)	20.2	16.4	-	-5.2%	-	-	优于大市
300015.SZ	爱尔眼科	医疗服务	1,168	35.6	41.4	48.8	57.6	32.9	28.3	24.0	20.3	17.2%	1.6	1.6	优于大市
1066.HK	威高股份	医疗器械	239	20.7	23.0	25.3	27.7	11.6	10.4	9.5	8.6	8.7%	1.5	1.5	优于大市
1789.HK	爱康医疗	医疗器械	62	2.7	3.3	4.0	4.8	22.5	18.5	15.3	12.7	10.4%	0.9	0.9	优于大市
2005.HK	石四药集团	化学制药	79	9.8	9.5	9.9	10.8	8.0	8.3	8.0	7.3	14.7%	2.6	2.6	优于大市
0512.HK	远大医药	化学制药	280	22.9	20.3	22.6	25.6	12.3	13.8	12.4	10.9	15.0%	3.6	3.6	优于大市
0013.HK	和黄医药	化学制药	192	2.7	24.9	8.5	11.8	70.9	7.7	22.5	16.3	5.0%	0.1	0.1	优于大市
2162.HK	康诺亚-B	生物药	122	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(23.8)	(15.3)	(21.0)	255.1	-20.8%	0.1	0.1	优于大市
9926.HK	康方生物	生物药	676	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(131.4)	2331.2	92.6	37.7	-7.6%	-9.3	-9.3	优于大市
1530.HK	三生制药	生物药	444	20.9	23.9	27.1	30.7	21.2	18.6	16.4	14.5	13.5%	1.4	1.4	优于大市
6990.HK	科伦博泰生物-B	生物药	704	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(264.0)	(97.7)	(233.2)	148.3	-8.1%	0.4	0.4	优于大市
2480.HK	绿竹生物-B	生物药	44	(1.7)	(1.5)	(1.3)	1.2	(26.0)	(30.0)	(34.4)	37.7	-19.7%	0.2	0.2	优于大市
2268.HK	药明合联	CXO	459	10.7	14.0	19.2	26.0	42.9	32.9	24.0	17.7	16.1%	1.0	1.0	优于大市

2273.HK	固生堂	医疗服务	83	3.1	3.8	4.8	6.1	27.0	21.9	17.2	13.6	12.9%	0.9	优于大市
2666.HK	环球医疗	医疗服务	94	20.3	21.2	22.0	22.9	4.6	4.4	4.3	4.1	11.8%	1.1	优于大市
2522.HK	一脉阳光	医疗服务	55	(0.5)	0.5	0.8	1.1	(120.5)	112.9	68.3	48.9	-3.2%	-0.5	优于大市

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

注：总市值以 2025/06/06 股价计算

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032